

Personnummer

19480527-5023

Namn

Britt Ingela Bryngelsson

GÄRDESVÄGEN 4

47540 HÖNÖ

Mobiltelefon: 07399-17055

ANKOM

2024-01-02

bäckenet

LCA06 Biopsi av endometriet

Signerad av: Irina Ktsoeva, Specialist läkare Gynekologi

Signerad av: Irina Ktsoeva, Specialist läkare Gynekologi

2022-11-01, Helmut Pschera, Specialist läkare Gynekologi

Gynekologgrupp LÄK nybesök

Kontaktersak

Flytning. Obehagskänsla. Remiss från Hönö vårdcentral.

Anamnes

III-para, PN. MP innan 50 åå. Aldrig systemisk Ö2.

Tidigare sjukdomar

Op x flera för både njursten och njurcancer, 1/4del av vä njure borta. Hypertoni. Sarkoidos. Gikt bl a.

Aktuellt

I somras fått Donaxyl mot BV. Har i jan börjat med Vagifem, orolig när hon läst bipacksedel. Klåda. Undrar ang cellprov, bara fina cellprover i cytburken, senast 2008. Inga blödningar.

Buk

Gyn

IU: Senilatrofiska förhållanden generellt vad gäller vvp, ej kolpit. Ospec vagfluor. Uterus palp ua. Sid 0. Vag ULJ: invändningsfritt. Uterus med flertal spridda kalkhärddar. Ovarier svåridentifierbar. Ingen fri vätska. Klar urin i blåsan.

Bedömning/Åtgärd

Normalt gynstatus för åldern. Byter till det billigare Ovesterin både vag + kräm. Remissvar

Diagnos

N952 Atrofisk vaginit efter menopausen

Z014 Gynekologisk undersökning (allmän) (rutin)

Signerad av: Helmut Pschera, Specialist läkare Gynekologi

Åtgärd

AL003 Vaginal ultraljudsundersökning av uterus, adnexa och lilla bäckenet

Signerad av: Helmut Pschera, Specialist läkare Gynekologi

Signerad av: Helmut Pschera, Specialist läkare Gynekologi

Personnummer

19480527-5023

Namn

Britt Ingela Bryngelsson

GÄRDESVÄGEN 4

47540 HÖNÖ

Mobiltelefon: 07399-17055

2023-12-20, Irina Ktsoeva, Specialist läkare Gynekologi

Gynekologgrupp LÄK nybesök

Kontaktorsak

Första besök. Remiss från Hönö vårdcentral p g a förtjockat endometrium och önskan om endometriebiopsi.

Aktuellt

Kvinnan är känd hos oss sedan tidigare. Har varit på besök hos oss den 1/11 2022 också på remiss från Hönö vårdcentral. 3-para med partus normalis. Är i menopaus vid 50 års ålder. Inte haft postmenopausala blödningar. Opererats gånger flera för både njursten och njurcancer. Har hypertoni. Sarkoidos. Gikt. Nu i januari fick hon lungemboli bilateralt. Hjärtflimmer och fladder. Utredning pågår. Sökte för cirka ett halvår sedan Kungälv lasarett där man konstaterade förtjockat endometrium, endometriebiopsi enligt inremittent visar normalt resultat. Önskas ny bedömning av endometrium som ett led i uteslutande av bakomliggande malignitet (gynekologisk malignitet).

Buk

Gyn

VVP: atrofiska slemhinnor. Portio högt upp och svårt att nå till slut lyckas jag att se portio makroskopiskt u a. Palpation svårt att palpera inre könsorgan p g a fet bukvägg.

Vaginalt ultraljud visar anteflekterad normalstor uterus med förtjockat endometrium AP 10 mm. Corpuspolyp? Hyperplasi av endometrium? Ovarier svårt att visualisera dock inga cystor på platsen för ovarier. Ingen fri vätska i magen.

Provtagning: endometriebiopsi med måttligt utbyte och begäran om snabbsvar.

Gör idag hydrosoneografi: en klotång sättes på främre portioläppen.

Med hjälp av tunn kateter sprutas cirka 20 ml koksaltlösning i uterus-kaviteten. Kaviteten vidgas. Man ser enbart ett förtjockat endometrium. Ingen corpuspolyp.

Bedömning/Åtgärd

Hyperplasi av endometrium, dock inga postmenopausala blödningar. Avvaktar PAD-svar. Lovar provsvar till patienten via telefonsamtal. Vid påvisad malignitet bör patienten komma till läkare för cancerbesked och åtgärd.

Diagnos

Journalkopia skickas som remissvar till inremittent.

N952 Atrofisk vaginit efter menopausen

Z014 Gynekologisk undersökning (allmän) (rutin)

Åtgärd

Signerad av: Irina Ktsoeva, Specialist läkare Gynekologi

AL003 Vaginal ultraljudsundersökning av uterus, adnexa och lilla

PAT/CYT-SVAR**Remissid**
26717415**Patient**
19480527-5023
Britt Ingela Bryngelsson**Beställare****Avsändare Pat/Cyt-svar**
Unilabs**Svarsstatus**
Slutsvär**Provtagningsstid**
2023-12-20**Undersökning****Resultat**

LID: VG-P23-044010

PROVLOKALISATION ENLIGT INREMITTERANDE:

Lokalisation : Uterus

Provbeskrivning:

A) Endometrium, Corpusskrap/endometriebiopsi

Makroskopisk:

A) Mängd skrap= måttligt.

Mikroskopi:

A) Mikroskopisk undersökning visar måttlig mängd endometrium med ganska kompakt stroma och lågt antal körtlar och ytepitel från endometrium med benign morfologi. Ingen proliferationsaktivitet påvisas.

Huvuddiagnos:

A) Endometrium utan belägg för malignitet, inaktiv/atrofisk bild.

Klaudia Svensson

2023-12-27

